

Wczesna *interwencja*

Każdy tydzień bez leczenia pogarsza rokowanie. Najsilniejszy modyfikowalny predyktor dobrego wyniku to czas reakcji.

CZAS: 15 min Pierwsza wizyta · psychoedukacja

ŹRÓDŁO: Marshall i in. (2005); Morrison i in. (2004, EDIE); McGorry i in. (2010); Yung i in. (2007, CAARMS)

JAK UŻYWAĆ

Naucz się **5 sygnałów ostrzegawczych** psychozy i zaplanuj *konkretną ścieżkę reakcji*: do kogo dzwonisz w ciągu 24 h, kogo informujesz, jakie kroki podejmujesz. Wypełnij listy w sekcjach 4-5, zachowaj kartę w widocznym miejscu, omów ją z osobą wspierającą.

DLACZEGO TO DZIAŁA

DUP (ang. *Duration of Untreated Psychosis*) — czas nieleczonej psychozy — to **najsilniejszy modyfikowalny predyktor** długoterminowego rokowania. Meta-analiza Marshall i in. (2005): krótszy DUP koreluje z *lepszą* remisją objawów, lepszym funkcjonowaniem społecznym i mniejszym ryzykiem nawrotu. **DUP poniżej 6 miesięcy → 2x lepsze rokowanie.** W okresie zwiększonego ryzyka (ang. *Ultra-High-Risk, UHR*) terapia poznawczo-behawioralna redukuje konwersję do psychozy o ok. 50% (Morrison, 2004, EDIE).

01 ✕ Pięć sygnałów ostrzegawczych

Sygnały te w izolacji **nie oznaczają** psychozy — większość ludzi czasem ich doświadcza. Niepokoi *nakładanie się kilku*, ich *narastanie* w czasie i *spadek funkcjonowania*: w nauce, pracy, relacjach.

1 · WYCOFANIE SPOŁECZNE

Coraz rzadsze kontakty, unikanie rodziny i przyjaciół, izolacja w pokoju przez dni lub tygodnie. *Bez wyraźnej przyczyny.*

2 · PODEJRZLIWOŚĆ

Poczucie, że ktoś *obserwuje, spiskuje, coś planuje*. Trudność z zaufaniem nawet bliskim. „Coś jest nie tak, ale nie wiem co”.

3 · DZIWNE PRZEKONANIA

Pojawia się myśl: „*to nie mogło być przypadkiem*”, „*znaki są dla mnie*”. Niezachwiana pewność co do rzeczy, które innym wydają się zbiegiem okoliczności.

4 · ZABURZENIA SNU

Spadek snu poniżej 5 godzin przez kilka nocy z rzędu, odwrócenie rytmu (sen w dzień, aktywność w nocy), brak potrzeby snu mimo zmęczenia.

5 · SPADEK FUNKCJONOWANIA

Pogorszenie w nauce, pracy, codziennych obowiązkach. Niemożność skupienia, gubienie wątków, opuszczanie zajęć. Higiena schodzi na drugi plan. **To często pierwszy zauważalny dla otoczenia sygnał.**

02 ↓ Ścieżka reakcji — co robić



Nie czekaj na „pełną psychozę”. Skontaktuj się ze specjalistą już przy *kilku* sygnałach ostrzegawczych. Pierwszy epizod zawsze wymaga pełnego badania somatycznego — wykluczenia przyczyn organicznych (encefalopatia anty-NMDA, padaczka, guz, infekcja).

03 Okres zwiększonego ryzyka — co działa

Okres **zwiększonego ryzyka** (ang. *Ultra-High-Risk*, UHR) to faza *subklinicznych* objawów — pojawiają się sygnały, ale nie spełniają jeszcze kryteriów psychozy. Konwersja do pełnego epizodu: **30-40%** w ciągu 2-3 lat. Interwencja w tym okresie redukuje konwersję mniej więcej o **połowę** (Morrison, 2004, EDIE).

CBT ZORIENTOWANA NA PRODRAM

Łagodne kwestionowanie subklinicznych przekonań, normalizacja, redukcja stresu.

Najsilniejszy dowód — protokół EDIE-2 (Morrison i in., 2012).

KWASY OMEGA-3

1,2 g EPA+DHA dziennie przez 12 tygodni — McGorry i in. (2010). Neuroprotekcja. Decyzję podejmij z lekarzem.

HIGIENA SNU I ODSZAWIENIE SUBSTANCJI

Regularny rytm 7-9 h, **brak THC** (silnie zwiększa ryzyko konwersji), ograniczenie alkoholu i amfetaminy. Te trzy decyzje obniżają próg.

KONTROLE CO 3 MIESIĄCE

Regularne wizyty kontrolne. Antypsychotyk *tylko* wtedy, gdy spełnione są kryteria pełnej psychozy. **Lepiej obserwować niż przeleczyć.**

04 Mój osobisty plan reakcji

MOJE SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE

— *jak wyglądały u mnie albo czego się obawiam*

PIERWSZA OSOBA DO KONTAKTU

— *imię, telefon*

MÓJ PSYCHIATRA / PORADNIA

— *nazwa, telefon, godziny*

SUBSTANCJE, KTÓRE ODSZAWIAM

— *THC, alkohol, inne*

Klucz: meta-analiza Marshall i in. (2005) na ~5000 pacjentach: **każdy miesiąc opóźnienia leczenia** w pierwszym epizodzie pogarsza długoterminowy wynik — korelacja DUP z funkcjonowaniem $r = -0,4$. Programy wczesnej interwencji (RAISE-ETP, Kane i in., 2016) **podwajają** szanse na utrzymanie pracy/nauki po 2 latach. **Najsilniejszy modyfikowalny czynnik to czas reakcji** — nie czekaj, aż objawy „same przejdą”. W kryzysie: **116 123** (telefon zaufania, 24/7) lub **112**.